isp zürich
Institut für Sexualpädagogik und Sexualtherapie

Master of Arts Sexologie

Block 2

Sexuelle Entwicklung von Kindern aus Sicht des Modells Sexocorporel

Ben Kneubühler, Studienleiter

Agnes Silvani, Co-Masterstudiengangsleiterin

ISP Zürich

Lernziele Block 2

- haben die nächsten Lerngruppenterminen vereinbart
- verfügen über einen Einblick in das Modell Sexocorporel
- kennen die Grundlagen sexueller Entwicklung im Kindesalter und in der Vorpubertät nach dem Modell Sexocorporel
- kennen den Einfluss des archaischen Modus auf die Sinnesempfindung und die Gestaltung der Sexualität als Erwachsene
- haben einzelne Elemente ihres Entwicklungs- und Sexualisierungsprozesses reflektiert

Programm Samstag

9:15 Uhr – 12:00 Uhr

(12:00 – 12.30 Infoplattform)

13:45 – 17:15 Uhr

- Entwicklungstheorien
- Sexuelle Entwicklung nach Sexocorporel I
- Imaginationsübung

Programm Sonntag

9:15 Uhr – 12:30 Uhr

13:45 – 17:15 Uhr

- Sexuelle Entwicklung nach Sexocorporel II
- Sensorik
- Der archaische Erregungsmodus

Thematische Einordnung

Modul 1 Interdisziplinäre Grundlagen der Sexualwissenschaft, der sexuellen Gesundheit und Einführung in das Modell Sexocorporel

	Datum	Inhalt	Dozent*in
Block 1	03.-04.04.2025	Einführung in das Masterstudium: Einführung in Sexocorporel, Gruppenbildung	BK/AgS
Block 2	05.-06.04.2025	Sexuelle Entwicklung von Kindern aus Sicht des Modells Sexocorporel	BK/AgS
Block 3	02.-03.05.2025	Einführung in das Masterstudium: Interdisziplinäre Sexualwissenschaft und Forschung (inkl. Überblick über wissenschaftliches Arbeiten: Bibliotheksnutzung, Einführung in den Reader)	HJV
Block 4	16.-17.05.2025	Körperwahrnehmung im Kontext Selbst- und Fremdwahrnehmung Teil 1, *Selbsterfahrung*	SR
Block 5	23.-24.05.2025	Sexualität Erwachsener aus der Sichtweise des Modells Sexocorporel, inkl. kognitiver Aspekte	HJ
Block 6	20.-21.06.2025	Sexuelle Entwicklung Jugendlicher aus Sicht des Modells Sexocorporel	AgS
Block 7	27.-28.06.2025	Komponenten des Modells sexueller Gesundheit nach dem Modell Sexocorporel: Sexodynamik	EES
Block 8	18.-19.07.2025	Sexualität Erwachsener aus der Sichtweise des Modells Sexocorporel: physiologischer Aspekte	BK/AgS

Thematische Einordnung

Modul 2 Interdisziplinäre Grundlagen der Sexualberatung und der Sexualforschung

	Datum	Inhalt	Dozent*in
Block 11	24.-25.10.2025	Sexuelle Bildung Einführung	SD
Block 12	31.10.–01.11.2025	Komponenten des Modells sexueller Gesundheit nach dem Modell Sexocorporel: Beziehungsaspekte	EES
Block 1J	07.-08.11.2025	Joker: Mögliches Verschiebedatum	
Block 13a	21.-22.11.2025	Themenfokussierte Selbstwahrnehmung Teil I: Gruppe I *in der Halbklasse*	PG / ZGS
Block 13b	28.-29.11.2025	Themenfokussierte Selbstwahrnehmung Teil I: Gruppe II *in der Halbklasse*	PG / ZGS
Block 14	12.-13.12.2025	Historische Perspektiven auf Sexualkultur und Sexualwissenschaft **online**	KW
Block 15	16.-17.01.2026	Psychosexuelle Entwicklung der Kinder	MB
Block 16	30.-31.01.2026	Sexuelle Entwicklung, Sexualität und Partnerschaft im Jugendalter	MB

Entwicklung

Entwicklung- was heisst das?

Entwicklung ist…

Einzelarbeit

Stichworte für sich selbst,

gerne mit Zeichnung dazu

Entwicklung- was heisst das?

Im Plenum einander vorlesen

Entwicklung ist....

Austauschen mit dem Fokus:

Was habe ich neu erkannt?

Ziele für Modul 1-2

Sich mit Zielen befassen heisst, sich entwickeln zu wollen

Einzelarbeit: Überlege dir ein persönliches, sowie ein berufliches explizites (überprüfbares) Ziel für den nächsten 2 Modulen (1 Jahr)

Hausaufgabe: *3 persönlichen und 3 beruflichen Lernzielen (siehe Studienorganisation) einreichen (unter Students (www.students.isp-zuerich.ch) „Abgaben“ – „Lernziele“) bis* ***31.05.25***

Beispiele

Berufliche Ziele	Persönliche Ziele
Ich gewinne während des Jahres an Sicherheit in Gespräch zu Themen rund um die Sexualität, sei es mit Eltern oder anderen Erwachsenen und natürlich mit Kindern und Jugendlichen. Dass ich Sicherheit gewonnen habe, erkenne ich an meinem ruhigen Atem beim Sprechen.	Ich lerne meinen Körper und mein Geschlecht besser kennen und wahrnehmen. Dabei helfen mir verschiedene Übungen zur Stärkung der Körperwahrnehmung und ein bewusstes Spiel mit den drei GdK in der Sexualität. Meine Erkenntnisse und Erfahrungen sowohl im Solosex, wie auch in der Paarsexualität halte ich mindestens einmal monatlich im Tagebuch fest.
Im Laufe des Studienjahres will ich anhand verschiedener Übungen und Methoden meine Auftrittskompetenz verbessern und sicherer in meinem Auftreten werden. Mein Ziel ist es, 3-4 verschiedene Methoden zu erlernen, welche mir das Sprechen und Auftreten vor Gruppen erleichtern	Es gelingt mir, meine verschiedenen Rollen als angehende Fachperson SXP, als Mutter von zwei Kleinkindern, als Ex-Partnerin und Frischverliebte, klar zu trennen. Dabei unterstützt mich eine klare körperliche Zentrierung bei einem Settingwechsel und ein Bewusstsein für meine Aufgaben in dieser Rolle.
Ich kann mein neugewonnenes und erweiteretes Wissen rund um Sexualität der Zielgruppe adäquat anpassen. Dies erkenne ich daran, dass mich die Zielgruppe zum Beispiel bei Erklärungen versteht.	Ich will anstehende Arbeiten immer zeitnah erledigen, um mir Stress zu ersparen. Die Lerngruppe erhält meine Erfahrungsprotokolle spätestens 10 Tage nach dem Block.

Kriterien für die Betrachtung von Lebensläufen

Entwicklung kann verstanden werden als:

- Abfolge von Stufen und Phasen
- Abfolge von Krisen / Krisenbewältigungen
- Auseinandersetzung mit:
  - Entwicklungsaufgaben
  - Lebensthemen
  - kritischen Lebensereignissen
  - gesellschaftlichen und kulturellen Herausforderungen

Quelle: Rahm, D. u.a.: Einführung in die Integrative Therapie, 1993

Entwicklungspsychologie

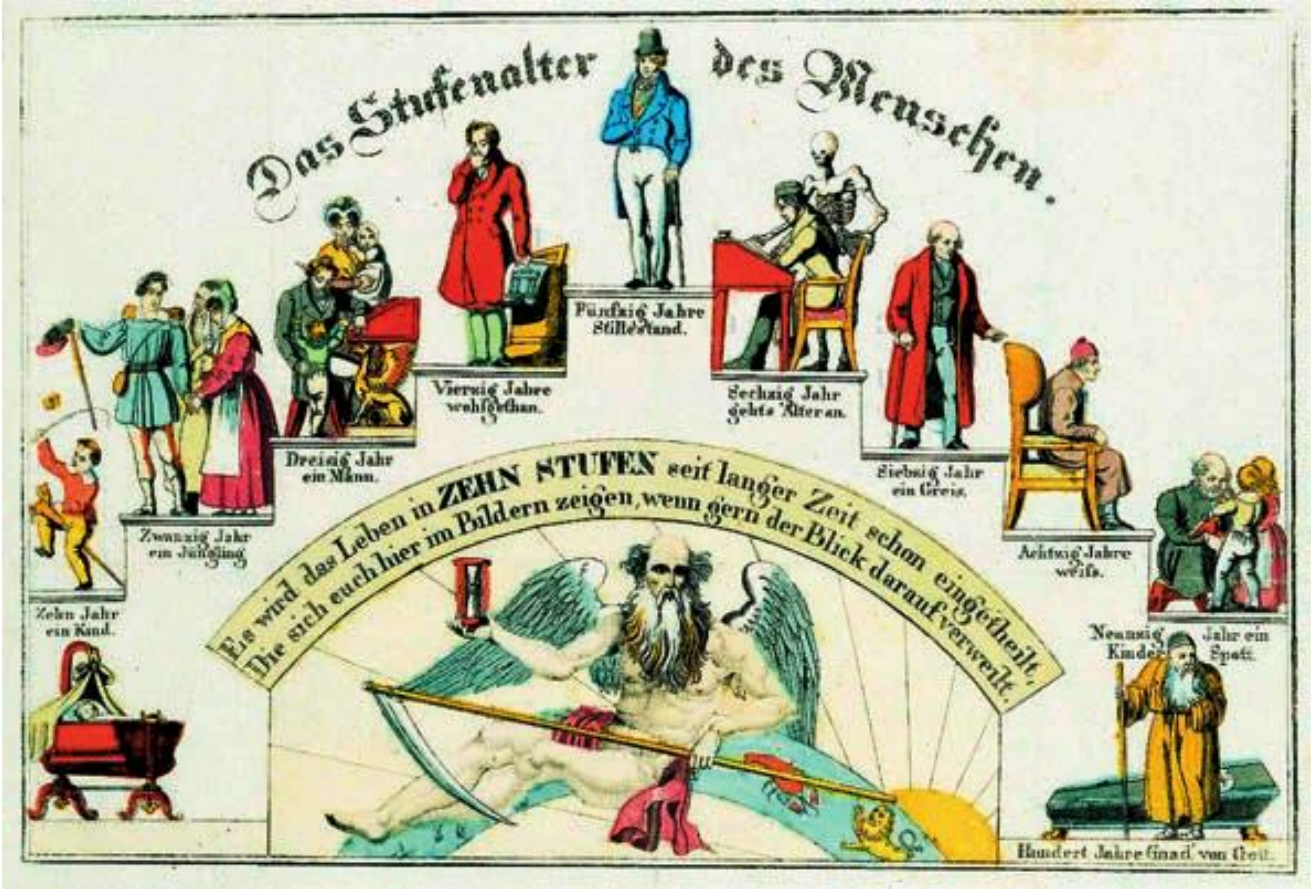
Definition: Entwicklung des Menschen

= Veränderungsprozesse des Individuums im Lauf des Lebens in den Bereichen:

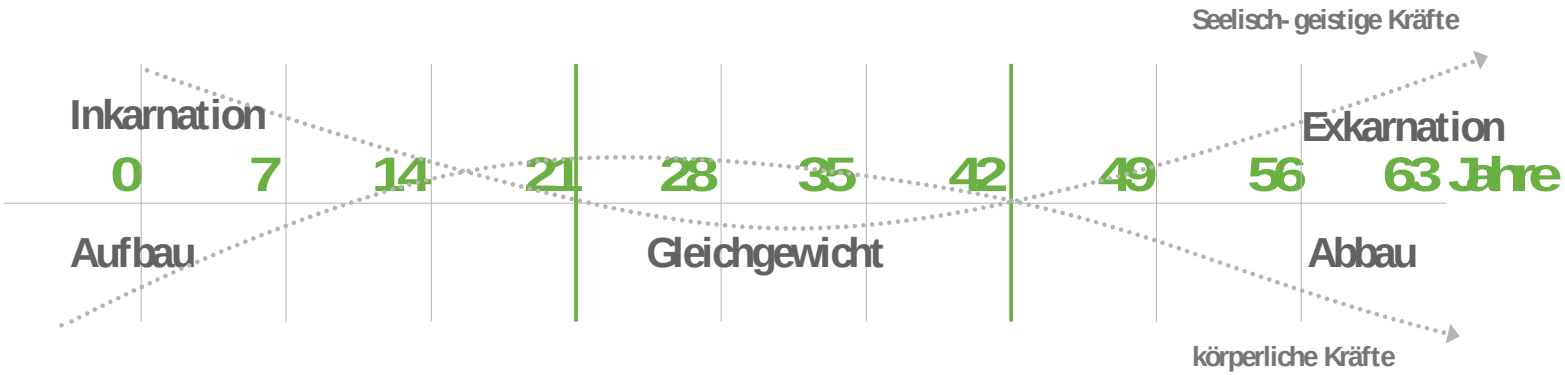
- des Körpers
- des Erlebens und Verhaltens
- des Denkens und
- der Einstellung

Das heisst, der Begriff „Entwicklung“ beinhaltet mehr als die Entfaltung von im Kern angelegten Merkmalen und Eigenschaften.

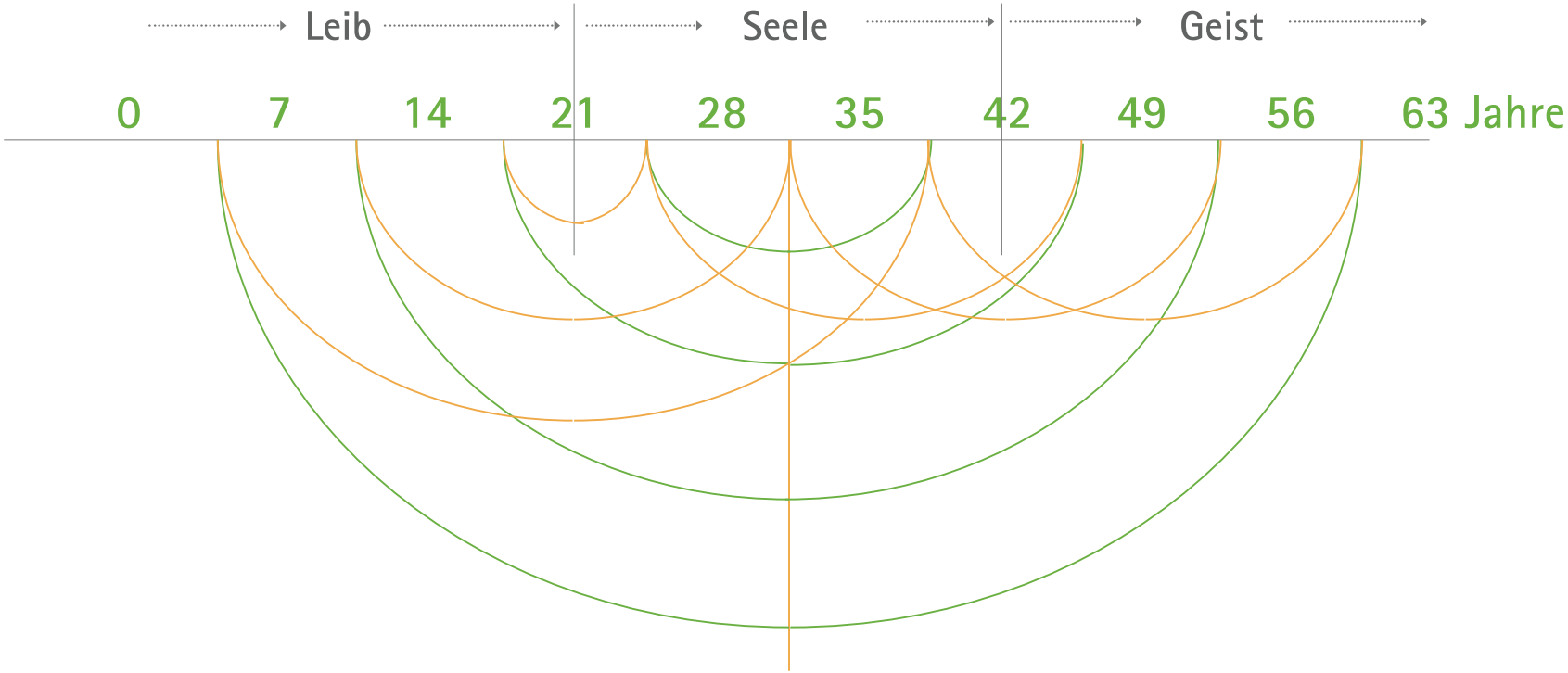
Entwicklungstheorien



Entwicklungstheorienach Rudolf Steiner



Entwicklungstheorien



Entwicklungspsychologie

Interdependente Entwicklungsbereiche

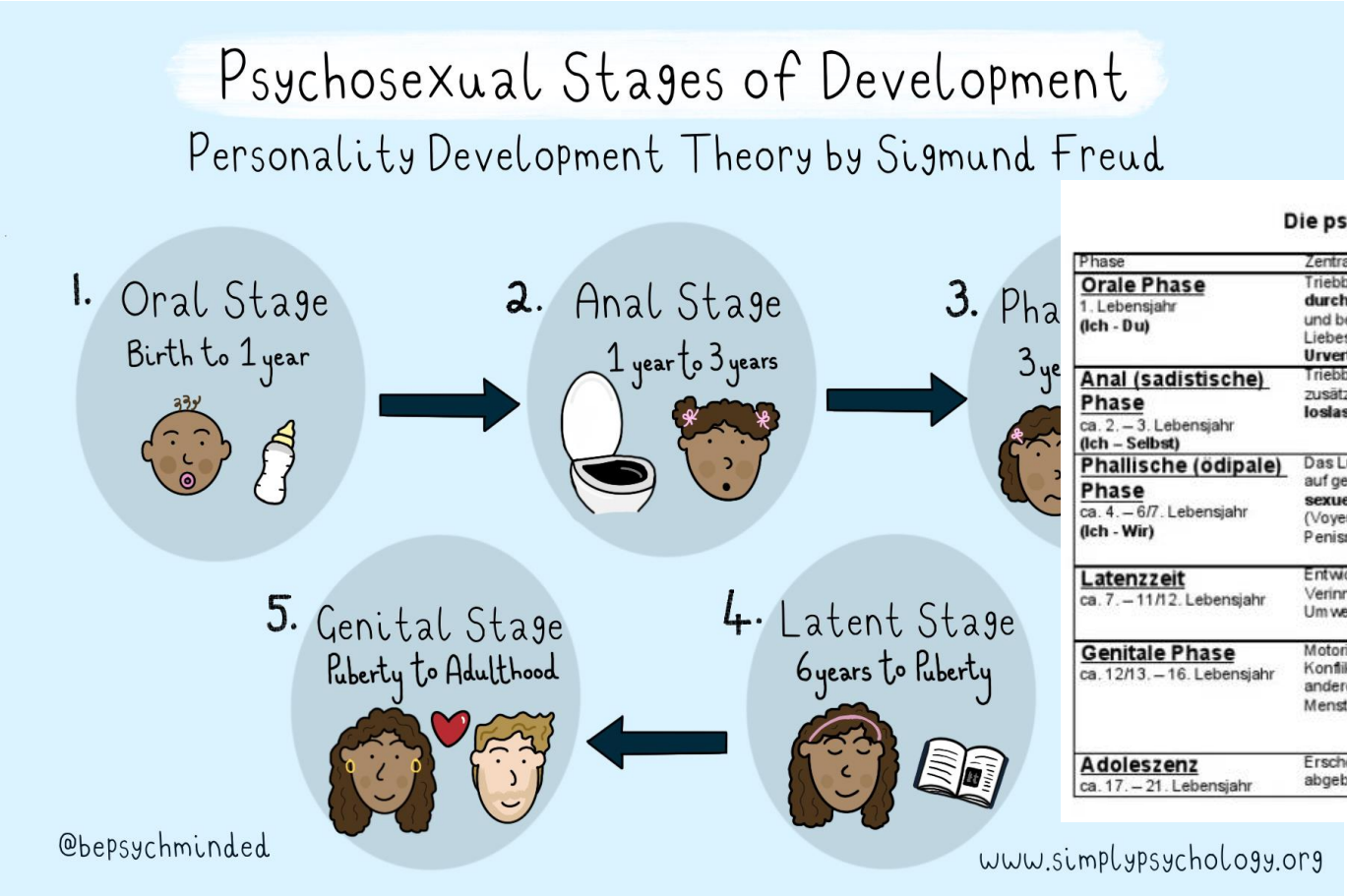
- Körper
- Körperausdruck
- Motorik
- Psyche
- Wahrnehmung
- Denken / Kognitionen
- Sprache
- Gedächtnis
- Emotionen
- Soziale Beziehungen
- Sexualität
- Bedürfnisse / Interessen
- Moral
- Autonomie
- Selbstkontrolle
- Bewusstsein, Selbstbewusstsein
- Geschlechtsrolle
- Identität
- Persönlichkeit

Entwicklungstheorien

- Freud
- Piaget
- Erikson

Aufgabe: Bezug zur eigenen Biografie herstellen (Notizen)

Freud



Die psychosexuellen Entwicklungsphasen nach Freud

Phase	Zentrales Erleben	Zentrale Themen	Mögliche Störungen
Orale Phase 1. Lebensjahr **(Ich - Du)**	Triebbefriedigung und **Lustgewinn durch** Nahrungsaufnahme, **saugen** und beißen. Angst vor Trennung, Liebesverlust, Objektverlust **Urvertrauen** oder Urmisstrauen	Bindung, Abhängigkeit, angenommen werden. Vom primären Narzissmus zu erster Objektbildung (Mutterbrust)	Schnelles Aufgeben, Sucht, Nähe-Distanz-Probleme, (Klammern oder ablehnen) Depressionen, Psychosen Selbstwertprobleme, Gier
Anal (sadistische) Phase ca. 2. – 3. Lebensjahr **(Ich – Selbst)**	Triebbefriedigung und **Lustgewinn** zusätzlich durch **zurückhalten und loslassen**. Angst vor Dominanz.	Macht über die Eltern erleben durch Defäkationskontrolle. (Sadismus)	Geiz oder Verschwendungssucht, Recht haben wollen, Phobien, Zwangsneurosen, Zwanghafter Charakter
Phallische (ödipale) Phase ca. 4. – 6/7. Lebensjahr **(Ich - Wir)**	Das Lustempfinden erweitert sich auf genitale Bereiche. **Erleben der sexuellen Unterschiede** (Voyeurismus und Exhibitionismus) Penisneid ♀ und Kastrationsangst ♂	Relativierung der Liebe zum Gegengeschlechtlichen und Identifizierung mit dem gleichgeschlechtlichen Elternteil. (Lösen des Ödipuskonfliktes) Über-Ich	Partnerprobleme, Sexualstörungen und Sexualängste dissoziative Störungen (Hysterie)
Latenzzeit ca. 7. – 11/12. Lebensjahr	Entwicklung des Selbstwertgefühls Verinnerlichung der Umweltanforderungen	Knüpfen von Beziehungen zu gleichaltrigen (meist gleichen Geschlechts)	Angst vor Konflikt, Autoaggressive Tendenzen, Verhaltensstörungen, Konzentrationsprobleme
Genitale Phase ca. 12/13. – 16. Lebensjahr	Motorische und innere Unruhe, Konfliktgeladen, Zuwendung zum anderen Geschlecht, Pubertät: Menstruation ♀ Pollution ♂	Triebwünsche und Geschlechtsidentität, eigene Fähigkeiten und Ihre Grenzen, Autonomiebedürfnis und Abhängigkeit von den Eltern	Störungen der Geschlechtsidentität, triebfeindliche Einstellungen, schwere Selbstwertprobleme, Manifestieren erster Süchte
Adoleszenz ca. 17. – 21. Lebensjahr	Erscheinungen der Pubertät werden abgebaut. Persönlichkeitsfestigung	Selbstständigkeit	

Jean Piaget`s Stufenmodell

Differenzierung des Selbst von den Objekten
Objektpermanenz: Objekte existieren permanent, auch wenn man sie gerade nicht unmittelbar sehen kann

Einfache Reflexe (Hand-Saugreflexe), Handlungen werden wiederholt, Koordination von Bewegungen, aktives Experimentieren

Konservierung: Fehlende Mengeninvarianz bei Formveränderung Visueller Eindruck
Egozentrisches Denken: Schwierigkeiten, den Standpunkt Anderer zu Übernehmen
→ Drei Berge Versuch
Irreversibilität: Mangelnde Vorstellungen bezüglich einer möglichen Umkehrung von Prozessen

Erkennen, integrieren und koordinieren von Zusammenhängen
Reihenbildung: Fähigkeit Objekte anhand eines Kriteriums zu ordnen
Mentale Repräsentationen: Ganzheitliche Vorstellungen von konkreten Objekten (BSP: Karte zeichnen)

Abstraktes und hypothetisches Denken
Systematisches Hypothesentesten: Verändern einer Variable und konstant halten der anderen Variabeln
Kombinatorische Systeme und Strukturen durch planvolles Experimentieren entdecken

Präoperationales Stadium: (2-7 Jahre): Anschauliche Zeit

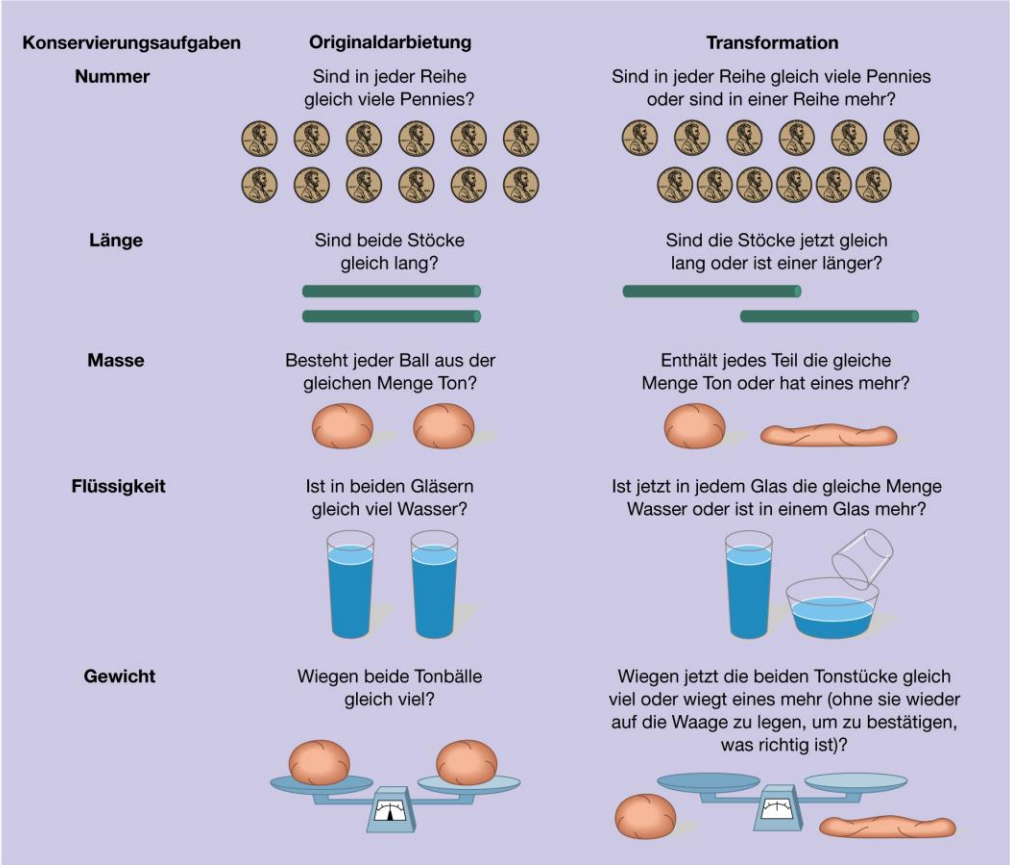


Abbildung 7.8: Einige Aufgaben von Piaget zur Invarianz (Konservierung). Kinder im voroperationalen Stadium können noch keine Invarianz (Erhaltung) von Mengen erkennen.

Stufen der psychosozialen Entwicklung nach Erikson

8 Lebensthemen

Stadien der psychosozialen Entwicklung

1. Vertrauen vs. Misstrauen
2. Autonomie vs. Zweifel (2-3-LJ)
3. Inititiative vs. Schuldgefühl (4-5 LJ)
4. Leistung vs. Minderwertigkeit (6—11 LJ)
5. Identifizierung vs. Rollenwechslung (10-18 LJ)
6. Intimität vs. Isolierung
7. Produktion vs. Stagnation
8. Lebenserfülltheit vs. Verzweiflung

Zur Vertiefung: Erikson Stufenmodell • psychosoziale Entwicklung · [mit Video] (studyflix.de)

Stadium1: Ur-Vertrauen vs. Ur-Misstrauen (1. LJ)

- Du vertraust darauf, dass sich deine Bezugspersonen um dich kümmern.
- Am stärksten ist deine Bindung erst einmal zu deiner Mutter, schließlich hat sie dich neun Monate lang beschützt und ernährt.
- Du verlässt dich darauf, dass sie das auch weiterhin tut und für dein Wohl sorgt.

Stadium 2: Autonomie vs. Scham und Zweifel (2. bis 3. LJ)

- Wirst du in deiner Entdeckungsphase stark eingeschränkt, beginnst du zu glauben, dass deine Wünsche falsch und einfach inakzeptabel sind.
- Zweifel kommen auf und du schämst dich.
- Du entwickelst unter Umständen zwanghafte Charakterzüge und wirst sehr streng, perfektionistisch, selbstkritisch und zweifelst häufig an dir selbst.

Stadium 3: Initiative vs. Schuldgefühl (4. bis 5. LJ)

- Du lockerst die besonders enge Bindung zu deinen Eltern langsam und erweiterst den Kreis deiner Bezugspersonen durch andere Familienmitglieder.
- Du realisierst, dass jeder eine soziale Rolle innehat und du fügst dich in deine eigene ein.
- Du möchtest dich weiterentwickeln und den Grundstein für deine spätere Selbstständigkeit legen.

Stadium 4: Werksinn vs. Minderwertigkeitsgefühl (6. LJ bis Pubertät)

- Deine Neugier ist größer denn je und du möchtest ganz vorn mit dabei sein.
- Du willst überall zuschauen und gezeigt bekommen, wie du etwas Nützliches tun kannst.
- Du möchtest jetzt nicht mehr nur im Spiel so tun, als würdest du es den Erwachsenen gleichtun, sondern wirklich am Geschehen teilnehmen.

Stadium 5: Identität vs. Identitätsdiffusion (Jugendalter)

- Du setzt alles daran, das ganze Wissen, das du bis dato gesammelt hast, zusammenzufügen und zu analysieren.
- Du erhoffst dir dadurch Antworten auf all deine Fragen zu finden, ein Selbstbild zu formen und deinen Platz in der Gesellschaft zu finden.
- Dein Freundeskreis wird zu deiner zweiten Familie und trägt zur Festigung deiner Persönlichkeit bei.

Stadium 6: Intimität und Solidarität vs. Isolation (frühes Erw.)

- Dein Partner oder deine Partnerin und deine Freunde stehen dir am nächsten, also isoliere dich nicht von ihnen.
- Finde dich selbst in deinem/r Partner/in und achte auf ein ausgeglichenes Geben und Nehmen.
- Kooperationen mit Nahestehenden und Wettkämpfe mit Rivalen finden statt.

Stadium 7: Generativität vs. Stagnation und Selbstabsorption (Erw.)

Wenn aus der Liebe Kinder hervorgehen, bist du auf der siebten Stufe angekommen. Du bist jetzt verantwortlich für deinen Nachwuchs.

- Du schenkst ihm Geborgenheit und Sicherheit.
- Deine Kinder durchlaufen nun all die Phasen, die du schon hinter dir hast und benötigen deine Unterstützung.
- Dazu gehört auch, den Kleinen all das beizubringen, was sie in ihrem späteren Leben brauchen werden.

Stadium 8: Ich-Integrität vs. Verzweiflung (Hohes Erwachsenenalter)

- Laufe nicht vor der Furcht davon, sondern setze dich mit dem Thema auseinander.
- Blicke auf dein Leben zurück und akzeptiere die Dinge, die vielleicht hätten besser laufen können, denn sie haben dich zu dem gemacht, was du heute bist.
- Ziel ist es, dem Tod ohne Furcht gegenüberzustehen und zufrieden auf das eigene Leben zurückzublicken.

Sex. Entwicklung nach Sexocorporel
Mit dem eigenen Geschlecht und Körper vertraut werden,
bewohnen lernen

isp zürich

Kindliche vs. Erwachsene Sexualität

- **Sexualität ist mehr als Genitalsexualität**
  - Nicht nur Geschlechtsverkehr (Lustaspekt), auch
  - Identitätsaspekt,
  - Beziehungsaspekt,
  - lebensschöpferischer Aspekt
- **Infantile Sexualität**:
  - Sexualität des Menschen von der Geburt bis zum Erreichen der Pubertät.
  - Kindliche Sexualität darf daher nicht mit der erwachsenen Genitalität verwechselt werden.
- **Erwachsene Sicht nicht auf kindliches Verhalten übertragen!**
- Kindliche Sexualität ruft in Erwachsenen häufig **zwiespältige Gefühle**, **Verunsicherung** oder **Ablehnung** hervor.

Kindliche vs. Erwachsene Sexualität

Kindliche Sexualität	Erwachsene Sexualität
Sinnlichkeit/ Lust am Körpererleben (was genitale Fokussierungen nicht ausschließt)	Genitale Fokussierung der Sexualität (was Vielseitigkeit nicht ausschließt)
Symbolische Objektbesetzung, naives Begehren (z.B. Heiratsangebote an Elternteil)	Konkrete Wünsche, konkrete Objektbesetzung auf Basis sexueller Scripte
Symbolische Wünsche (z.B. Kinderwunsch im Rollenspiel)	Konkrete Wünsche (z.B. nach sexuellen Praktiken)
Symbolische Hingabe	Konkrete sexuelle Handlungen
Masturbation ohne Script/sexuelle Fantasie	Masturbation mit Fantasie (ggf. externalisierte Stimuli)
Handlungen sensomotorisch spontan, nicht notwendig zielorientiert	Handlungen i.d.R. geplant, divers motiviert und zielgerichtet
Phantasierte Fertilität	Reale Fertilität

Reflexionsfragen

isp zürich
Institut für Sexualpädagogik und Sexualtherapie

- Gab es Doktorspiele/Eltern-Spiele in meiner Kindheit?
- Waren mir diese angenehm/unangenehm?
- Habe ich mich genital stimuliert?
- Welche Rollenspiele habe ich am liebsten gespielt?

Kindliche Sexualität
Sinnlichkeit/ Lust am Körpererleben (was genitale Fokussierungen nicht ausschließt)
Symbolische Objektbesetzung, naives Begehren (z.B. Heiratsangebote an Elternteil)
Symbolische Wünsche (z.B. Kinderwunsch im Rollenspiel)
Symbolische Hingabe
Masturbation ohne Script/sexuelle Fantasie
Handlungen sensomotorisch spontan, nicht notwendig zielorientiert
Phantasierte Fertilität

Frühkindliche Entwicklung

- Sexualität ist ein Entwicklungsbereich genau so wie Motorik oder Sprache
- Ausgehend vom sexuellen Erregungsreflex bis zur partnerschaftlichen Sexualität
- Viele Lernschritte vom Kleinkind bis ins Erwachsenenalter, um die Sexualität zu kultivieren und im sexuellen Erleben einen Reichtum an Gefühlen zu erleben
- **Sexuelle Entwicklung verläuft in mehreren Zeitabschnitten, von der frühesten Kindheit bis ins Alter.**

Vor der Geburt bis zum ersten Monat

	männlich	weiblich
in Utero Sexueller Erregungs-reflex	Erektionen ab16. Schw.Woche	Vasokongestion nicht beobachtbar tritt aber auf

Zufälliges Greifen nach Penis und Vulva

Reflektorische Erregung beim Wickeln und Baden

Im 1. Monat angeborene Reflex-mechanismen	bei Berührung	Lubrikation und Anschwellen der Vulva

1. – 4. Lebensmonat

Angeborene Reflex-Mechanismen beginnen sich zu differenzieren

Bewegungen von erratisch bis koordiniert

Beginnt Einfluss zu nehmen

Der genitale Erregungsreflex kann nicht willentlich ausgelöst werden

Durch die Stimulation der genitalen und oralen Rezeptoren kommt es zur

➔ Vasokongestion

Erektion

Lubrikation

4. – 8. Lebensmonat

Psychomotorische Entwicklung

Langsame Aneignung des genitalen Erregungsreflexes durch:

➔ Zielgerichtete (Greif)- Bewegungen

➔ Wiederholtes Auslösen angenehmer Empfindungen (Beginn der Lustfunktion)

männlich	weiblich

Rhythmisches Pressen, Druck, Muskelkontraktionen
Spiel mit Muskelspannung im ganzen Körper

an Basis und Schaft des Penis	an Beckenboden und Vulva

➔Orgastische Entladung ist möglich

➔Archaischer Erregungsmodus

8. – 24. Lebensmonat

	männlich	weiblich
Wiederholen Gezielte Handbewegungen	• Wiederholung konsolidiert Können; • Neue Entdeckungen durch manuelle Stimulation der oberflächlichen Nervenrezeptoren • genital – anal – ganzer Körper ➔ Propriozeption ➔ Körperbild	
Aktives Experimentieren	Geschlechtsunterschiede werden wahrgenommen; GdG entwickelt sich; Neugier auf Geschlecht und Funktion wächst; Trotz macht Individuation möglich	
Zielgerichtetes Explorieren	Anale Exploration Spiel mit Penis	Anale Exploration Spiel mit Vulva

2 bis 6/7 Jahre

	Differenziertes Reiben am Penis	Spiel mit Vulva, Klitoris, Vaginaleingang
Motorische Fähigkeiten erlauben differenzierte Stimulation	Subtilerer Kontakt mit dem Geschlecht Streicheln und Reiben mit weniger Druck Aktivierung der Oberflächenrezeptoren	
	➔ Mechanischer Erregungsmodus	
Geschlechts-typische Spiele	Waffen Türme bauen Intrusivität	Höhlen bauen, Zelt, Puppen bemuttern Rezeptivität
Sexuelle Sozialisation	Darf das Geschlecht berührt werden? Eigener Raum? Toilette? Reaktion der Erwachsenen? Ermunternd? Verständnisvoll?	

7 bis 11 Jahre

Viele Spiele rund um den genitalen Erregungsreflex

Latenz existiert nicht. Kinder haben jetzt gelernt, eigene Räume zu nutzen (Keller, Garten, Baumhaus)

Regelspiele, die die Geschlechtsunterschiede konsolidieren
Verhandlung um Einvernehmen
Verführungsstrategien, um zu gefallen

Wenige Beobachtungen, da im Verborgenen gespielt wird

10 – 20 % entdecken Vagina mit den Fingern und Objekten

Interesse an Spielen mit «Schauen – Zeigen - Berühren»

Sexuelle Spiele mit dem gleichen Geschlecht und mit dem Anderen

11 - 16 Jahre

Pubertät

Spiele mit dem gleichen Geschlecht
Heterosexuelle Kontakte (AK)

Geschlechtsreife

- Erste Ejakulation
- Erste Menstruation

Initiationsspiele

«Wer geht mit wem?»
«Für wen wird geschwärmt?»
«Was ist IN?»

Zeit entscheidender körperlicher Veränderungen, die das Gefühl der Zugehörigkeit zum eigenen Geschlecht verstärken oder verunsichern.
Kernfrage: «Bin ich normal?»

Betonung der Geschlechter-differenz

- Penisgrösse
  Ejakulation
  Männliche Stereotypen
- Attraktivität
  Weibliche Stereotypen
  Menstruation
  Verhütung

Ab 16 Jahre

Die unterschiedlichen Erfahrungen und Aneignungen fördern oder begrenzen die Entwicklung sexueller Gesundheit.

Die Sexualentwicklung dauert lebenslang.
Lernschritte zur Verbesserung der eigenen Sexualität sind unabhängig vom Alter lebenslang möglich.

Fragen?

Imaginationsreise

isp zürich
Institut für Sexualpädagogik
und Sexualtherapie

Integration

- Gestalte deine Entwicklung mit Bastelmaterialien
- Anschliessend: Austausch in Gruppen

Sonntag – Tag 4

Isch no öpis?

Programm Sonntag

9:15 Uhr – 12:30 Uhr

13:45 – 17:15 Uhr

- Sexuelle Entwicklung nach Sexocorporel II
- Sensorik
- Der archaische Erregungsmodus

Embodiment

Sex. Entwicklung nach Sexocorporel
Mit dem eigenen Geschlecht und Körper vertraut werden,
bewohnen lernen

isp zürich

Reflexion Schreibe die Antworten direkt in dem Tagebuch (10 min)

1. Welche Entwicklungsschritte haben mich hilfreich in meiner Sexualität entwickeln lassen? Wer hat mich dabei hilfreich unterstützt, begleitet?
2. Welche Fähigkeiten habe ich daraus in Bezug auf meine Geschlechtlichkeit entwickelt, die mir heute noch zur Seite stehen?
3. Gibt es Erinnerungen an sexuelle Erregung?
   - Alter?
   - Ort und Handlung?
   - Körperreaktionen?
   - Gefühle dabei?
   - Gedanken?
   - Alleine? Zu zweit? In Gruppe?
   - Habe ich diese Handlung damals bereits mit Sexualität in Verbindung gebracht? Weshalb? Weshalb nicht?

Sexuelles Lernen ermöglichen

- Sexuelle Fähigkeiten werden gelernt & positive Unterstützung bildet den Rahmen für Lernen
- Lernen geschieht durch entdecken, verifizieren, wiederholen
- Erfahrungen haben Einfluss auf das spätere Erleben von Sexualität als Erwachsene
- Sexuelle Bildung als Prozess, bei welchem je nach Alter bzw. Entwicklungsstand der Kinder/Jugendlichen andere Aspekte im Vordergrund stehen
- «Talk before they can talk» (Pomeroy, 1974)
- Keine menschliche Fähigkeit wird in ihrer Entwicklung von Eltern und Gesellschaft so wenig unterstützt

Wie lernen Kinder und Jugendliche Sexualität?

isp zürich
Institut für Sexualpädagogik und Sexualtherapie

- von selbst, wenn sie nicht gestört werden,
- weil sie sich entwickeln wollen
- im Spiel probierend, vorbereitend auf Erwachsensein
- mit und an Erwachsenen
- über interessierte, empathische Anleitung
- über differenzierte Sprache
- über sinnliche Lernhilfen
- durch praktisches Üben

Kinder lernen Sexualität spielend

Durch **sensomotorische Spiele, Körpererkundungen, Rollenspiele, Imaginationsspiele**

- Entdecken des Geschlechts, seiner Form, seiner Erregbarkeit
- Sexuelle und emotionale Spannung auslösen, gestalten, entladen
- Erfassen des Geschlechtsunterschieds

- Sie entwickeln
  - sexuelle Lust
  - das Gefühl der Geschlechtszugehörigkeit
  - sexuelle Anziehung

Kinder lernen Sexualität spielend

Symbolische Spiele fördern das Beobachten

in diesen Imitationsspiele und Rollenspiele entwickeln und konsolidieren sie

- das Gefühl der Geschlechtszugehörigkeit
- auf der Ebene des Archetyps (Aufnehmend (Rezeptivität) oder Penetrierend (Intrusivität)
- auf der Ebene des Stereotyps
- die sexuelle Anziehung
- sexuelle Imagination, Fantasie
- Kommunikation und Verführung
- Sexuelles Begehren

Sexualität: Entwicklungspotenzial

Theorie des Modells Sexocorporel in 7 Grundpositionen

1 Körper und Psyche (Denken und Gefühlsleben) sind eine Zweieinheit. Sie spiegeln einander

2 Sexuelle Phänomene lassen sich in 4 Bereiche einteilen – die vier Komponenten

3 Ausgangspunkt für sexuelles Lernen ist der Körper

4 Sexualität wird gelernt und kann lebenslang weiter entwickelt werden

Sexuelles Lernen geht vom
vorgeburtlich vorhandenen genitalen Erregungsreflex aus...

Sexuelle Entwicklung nach Sexocorporel

- Sexualität ist ein Entwicklungsbereich, genau wie Motorik oder Sprache
- Sexuelle Entwicklung verläuft schrittweise, ausgehend vom sexuellen Erregungsreflex bis zur partnerschaftlichen Sexualität
- Vom Nicht-Bewusstsein (Reflexen) zum Bewusstsein (was tu ich?) und von der bewussten Wahrnehmung zur Kompetenz
- Sexuelle Entwicklung ist gekoppelt an Lernschritte auf der soziale ebene.
- Von Sinnesempfindungen zur Wahrnehmung über entdecken – wiederholen – verifizieren (Bewusstsein)

Grundposition 3
AUSGANGSPUNKT FÜR SEXUELLES LERNEN IST DER KÖRPER

Sexuelle Lernwege verlaufen von klein auf

Von der Aneignung des Körpers

↓

zur Entwicklung des Fühlens und Denkens

Vom Fokus auf die persönliche Entwicklung

↓

zur Bezogenheit auf andere (Beziehungsfähigkeit)

Grundposition 4
SEXUALITÄT WIRD GELERNT UND KANN LEBENSLANG WEITER ENTWICKELT WERDEN

Sexuelle Fähigkeiten werden durch eine Vielzahl von Lernschritten auf verschiedenen Ebenen **erworben**.

Definition Sexualität gem. SC

= Reflex

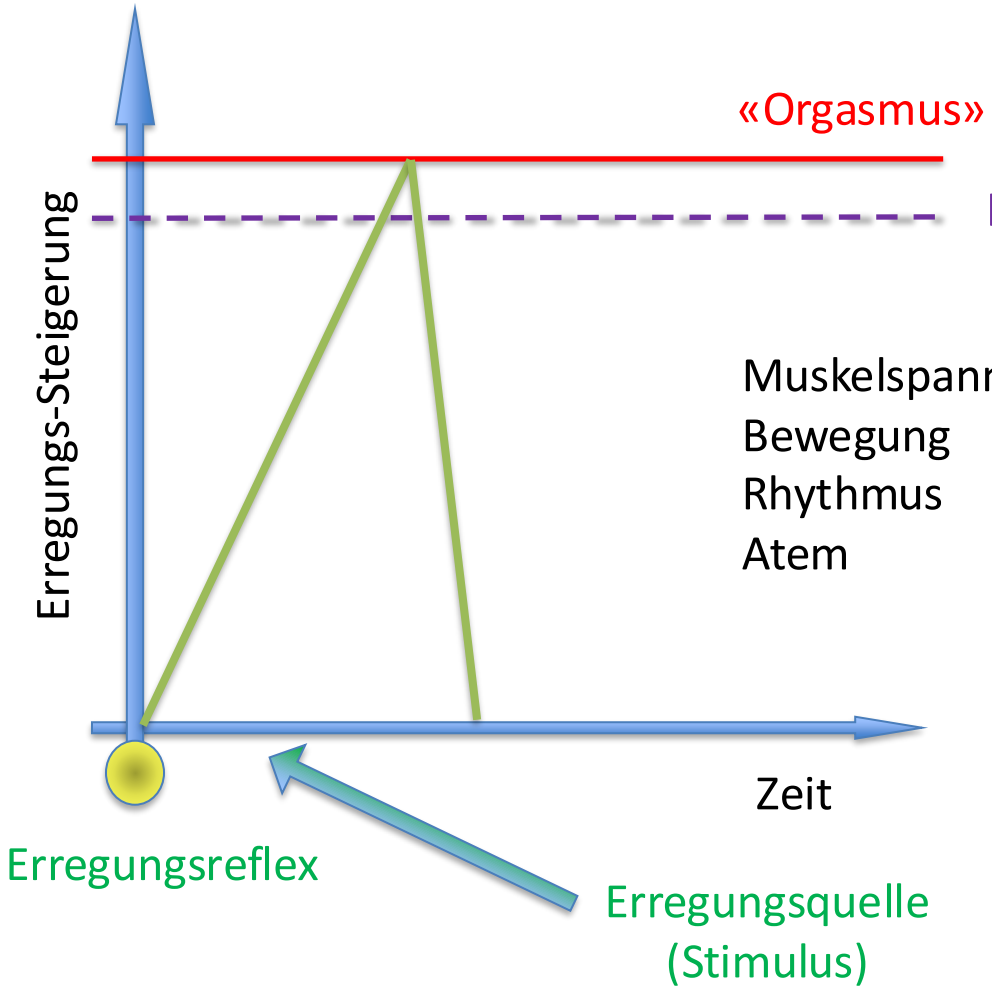
- Sexuelle Gesundheit – Sexuelle Gesundheit bedeutet bei Sexocorporel die Entwicklung der Erregungsfunktion. Sie ist die Basisfähigkeit, auf der emotionale Komponenten aufbauen.

- Die Erregungsfunktion = Auslösen des Erregungsreflexes, Erregungssteigerung,
  Erregungsdiffusion, Erregungssteuerung- und Modulation, Entladungsfähigkeit.

Grundgedanke Sexocorporel

Erregungsreflex

- **Die Erregung lässt sich in Form einer Kurve aufzeichnen.**
- Die physiologische Erregungskurve
- Die emotionale Erregungskurve (Lustkurve – Kurve der emotionalen Wertigkeit)
- **Ziel sind Entwicklungsschritte** um die Erregung im Körper steigern, modulieren, aufrecht erhalten, steuern zu können, entscheiden zu können, wann man kommt und das auch in einer Interaktion mit der Partnerin, dem Partner und dabei Lust zu empfinden.

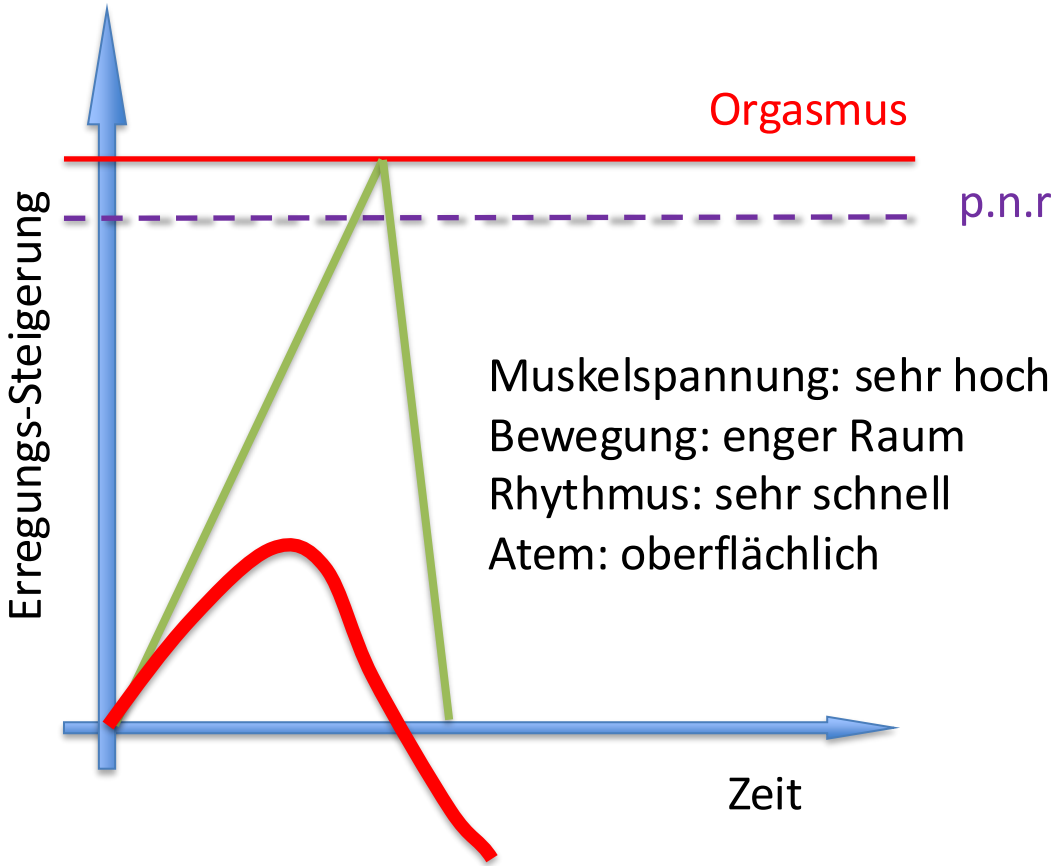


Muskelspannung
Bewegung
Rhythmus
Atem

Beeinflussen die Wahrnehmung der Sinnesreize

Emotionen

Unlust ←→ Lust

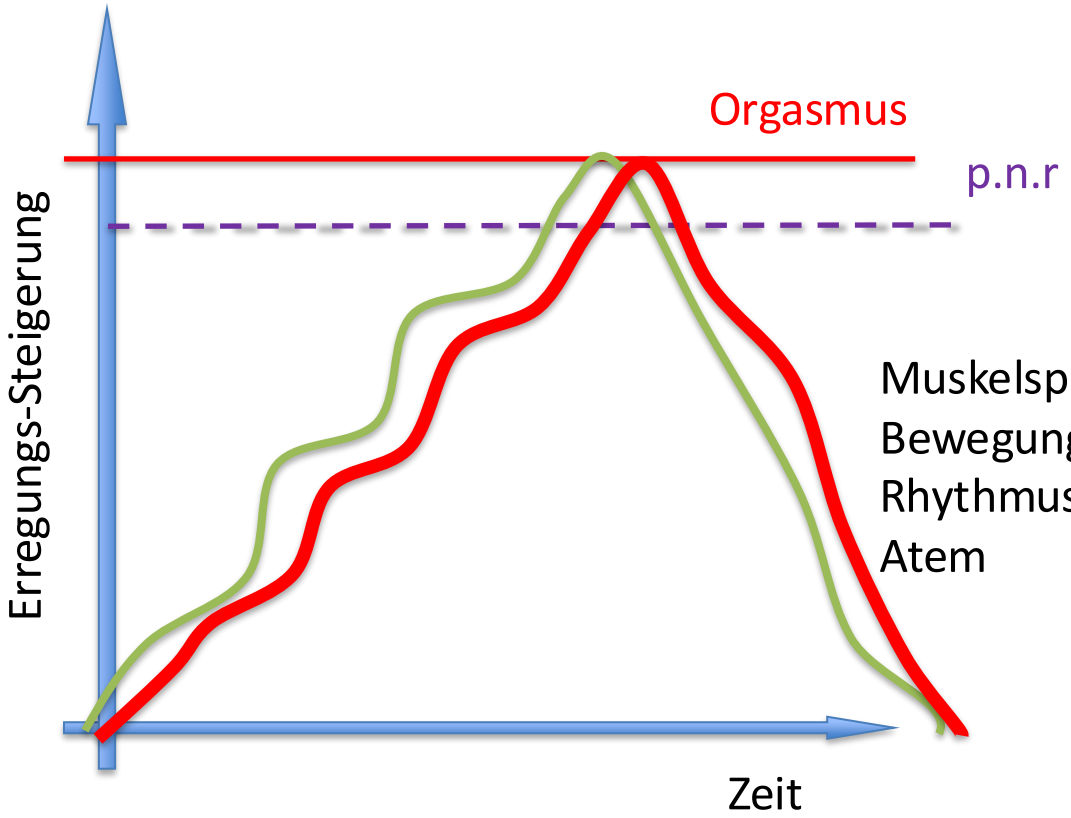


Muskelspannung: sehr hoch
Bewegung: enger Raum
Rhythmus: sehr schnell
Atem: oberflächlich

Beeinflussen die Wahrnehmung der Sinnesreize

Emotionen

Unlust



Muskelspannung
Bewegung
Rhythmus
Atem

Beeinflussen die Wahrnehmung der Sinnesreize

Emotionen

Lust

Spiel mit Spannung und Entspannung. Variation von Rhythmen, Grosser Bewegungsraum, Tiefatmung

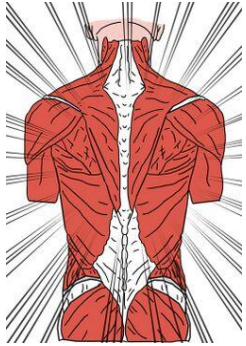
3 Gesetze des Körpers (3 GdK)

- Muskel – Tonus (mehr oder weniger angespannt)
- Rhythmus – Geschwindigkeit (Bewegungen können langsam oder schnell ausgeführt werden)
- Raum (Bewegung mit mehr oder weniger Platz einnehmen)

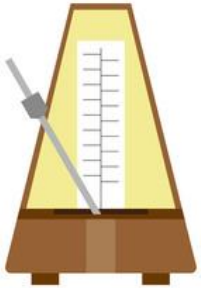
Spiel mit 3 GdK

Umhergehen im Raum - nutze die 3 GdK bewusst

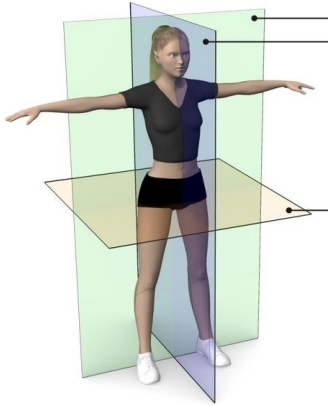
Tonus



Rhythmus



Raum



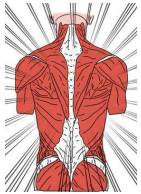
➜ Danach Austausch: was hast du beobachtet? Wie war der Kontakt mit den Anderen? Wie fühltest du dich?

Selbstreflexion Solosex (5 Min)

isp zürich
Institut für Sexualpädagogik
und Sexualtherapie

Auswirkungen 3 GdK auf das genussvolle sexuelle Erleben

isp zürich
Institut für Sexualpädagogik und Sexualtherapie



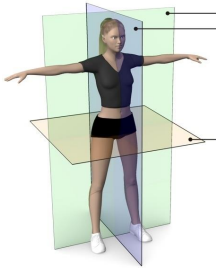
- Muskeln können bewusst mehr oder weniger angespannt werden.

  Für die genussvolle Sexualität heisst dies:

  „Variation ist oft mehr“

- Rhythmus: Bewegungen lassen sich schnell oder langsam ausführen.

  „In der Ruhe liegt die Lust“

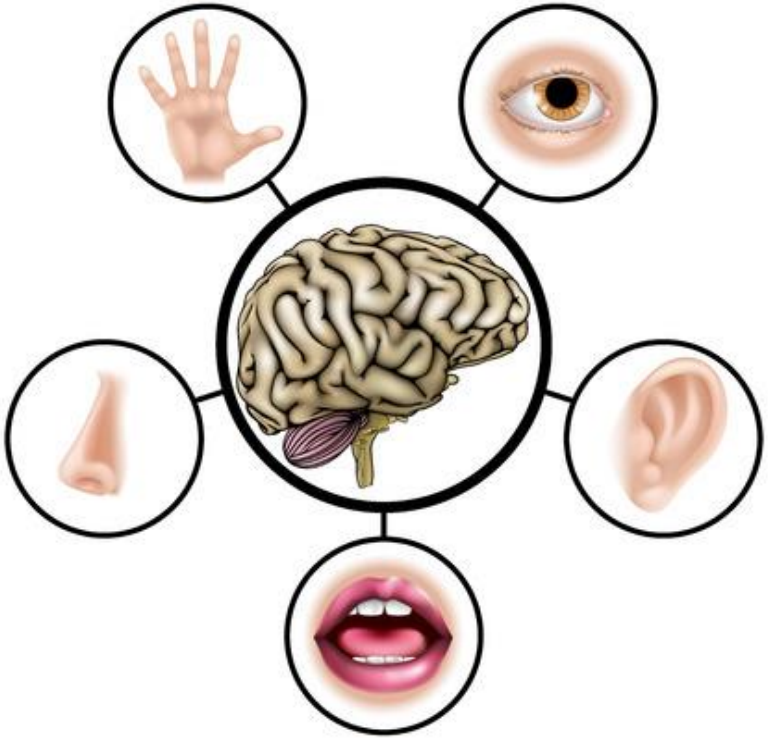


- Raum: Man kann mit dem Körper mehr oder weniger Platz einnehmen.

  „Mehr ist oft mehr“

Fragen?

Sensorik

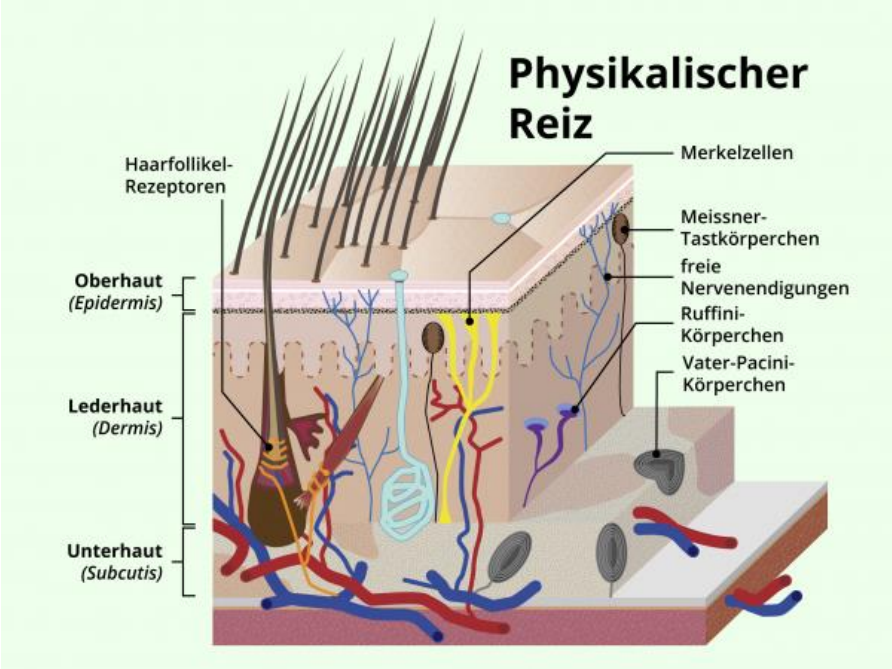


Sinnesreize - Haptik

- **Oberflächensensibilität**, also die Wahrnehmung mechanischer Reize wie Druck oder Vibration
- **Tiefensensibilität**, also die Wahrnehmung des eigenen Körpers im Raum, die Wahrnehmung der Gliedmassen zueinander und die Wahrnehmung von Körperbewegungen
- **Schmerz- und Temperaturwahrnehmung**

Reize und Rezeptoren

- Rezeptoren fast überall am und im Körper, v.a. auf der Haut
- Haarfollikel, Fingerspritzen, Zunge, Genitalien, Lippen...
- 5 mio. Haare, pro Haarfollikel 50 Rezeptoren
- Ständige Ruheaktivität



Vorgeburtlich

- Erstes Wahrnehmungssystem Vorgeburtlich: Embryo reagiert auf Berührungsreize (16mm)
- Tag 33 Motorneurone im Rückenmark nachweisbar
- 7 SSW: Lippen, 14 SSW: gesamter Körper
- Oberflächen aber auch in der Tiefe: Sehnen, Muskeln, Gelenke
- Ab 10 SSW: Berührungen des Gesichts, Streckbewegungen
- 12 SSW: Bewegung der Finger und Hände
- 17. SSW Lanugohaar, Rückbildung in 33. SSW
- Oxytocin wirkt Wachstumsfördernd

Fötale Selbstberührungen & Bewegungen

- Abhängig vom Entwicklungsstand und psychischen Zustand der Mutter
- Selbstregulation über Berührung am Gesicht, Herzschlag sinkt
- Erwachsene: 400-800 Selbstberührungen pro Tag

- Vom emotionalen Zustand und Verhalten der Mutter abhängig
- Ca. die Hälfte auf den Mund ausgerichtet

Körperkontakt

- Fehlender Kontakt löst Stressreaktion aus und mindert Gehirnentwicklung massiv (Tiermodell)
- Begriff- begreifen

Berührungen im Gesicht

- Selbstberührung ändert neurophysiologischen Zustand
- Emotionale Regulation
- Verhinderung Informationsverlust im Arbeitsgedächtnis
- Bändigen emotionaler Schwankungen

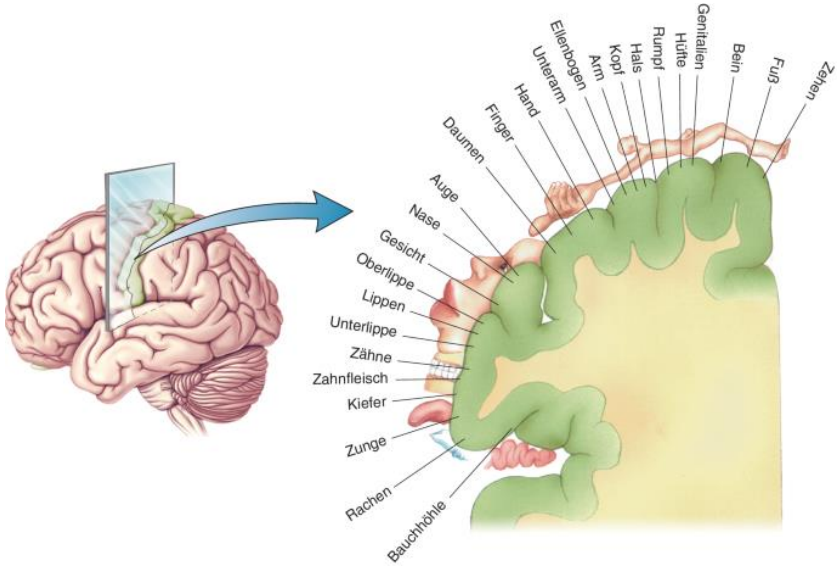
Einfluss auf Kognitionen

- heisses oder kaltes Getränk: Fahrstuhl-Experiment (Fremde Mensch als positiv/negativ eingeschätzt)
- leicht oder schwer: schwerer=wertvoller
- Raue oder glatte Oberfläche
- Hart oder weich (Unterlage zum Sitzen)

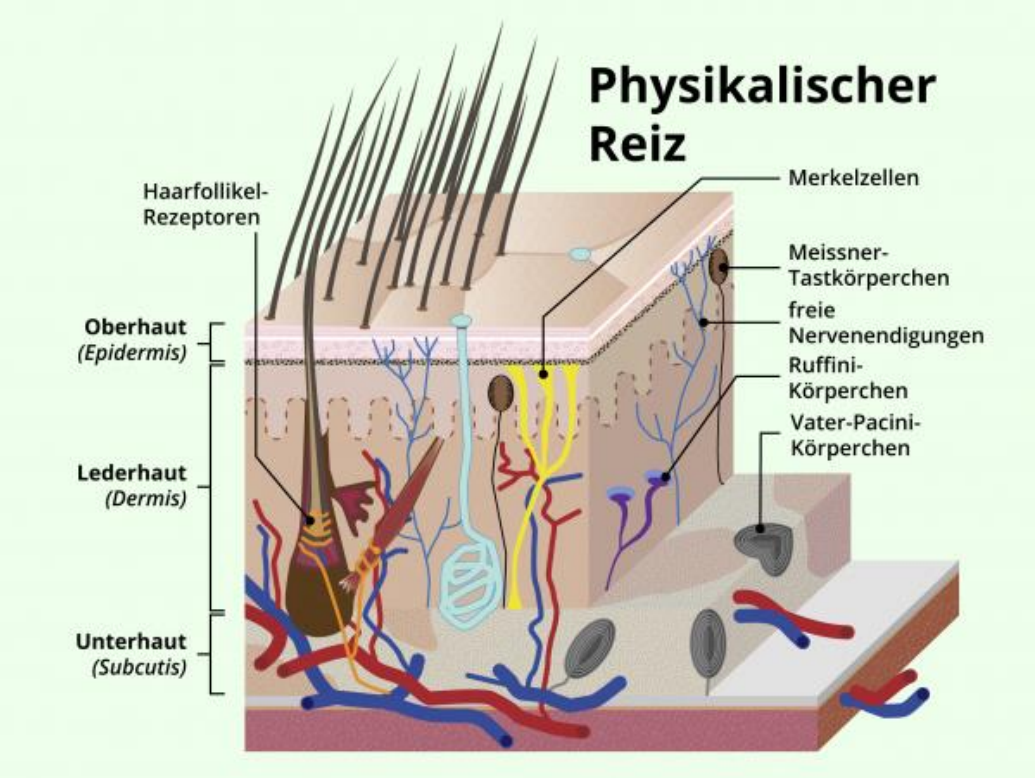
Von den Sinneseindrücken zur Wahrnehmung

Somatosensorik (Empfindungen **ausser** die klassischen 5 Sinne)

1. Sensorik der Körperoberfläche
2. Sensorik des Bewegungsapparats
3. Sensorik aus den inneren Organen



Von den Sinneseindrücken zur Wahrnehmung



Merkelzellen: Druck/Deformation und langsam adaptierend
Meissner: Druckveränderungen

Ruffini: Druck/Dehnung, Auswirkung Schwerkraft

Vater-Pacini: Vibrationen, Druckveränderung

Krause: Vibrationen, Temperatur

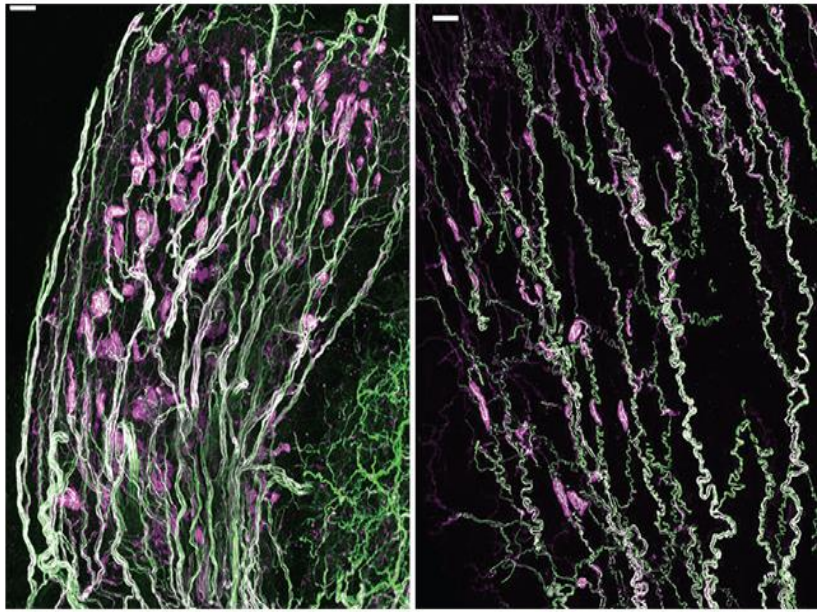
Freie Nervendigungen: Schmerz, Juckreiz, Temperatur

https://lernapp.info/lerntrack/physikalische-reize

Glans Clitoris

Several types of nerve terminations including **free nerve endings**, **genital endbulbs** as well as **Meissner**-like corpuscles and **Pacinian** corpuscles, but **not Ruffini** corpuscles, were found. (DOI: 10.1111/joa.13317)

Krause Corpuscules, also known as “corpuscles of pleasure” are particularly dense in the clitoris, are vibrotactile sensors crucial for normal sexual behavior(DOI: 10.1101/2023.06.14.545006)



Stained tissues showed concentrations of Krause corpuscles in clitoris (left) and glans (right) tissues. (Qi et al., bioRxiv, 2023)

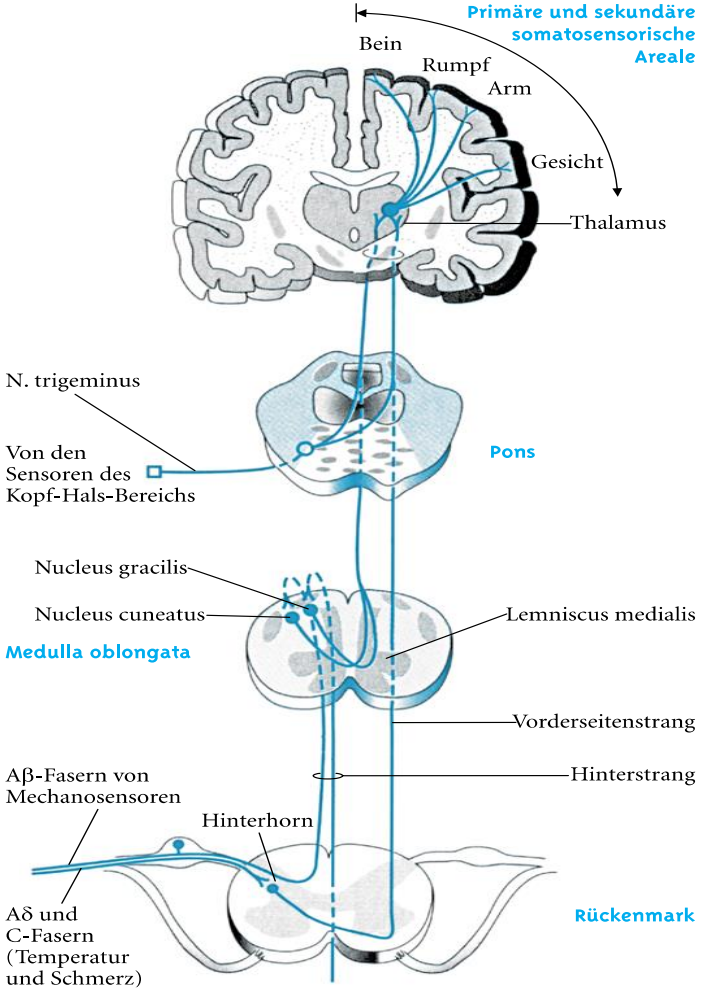
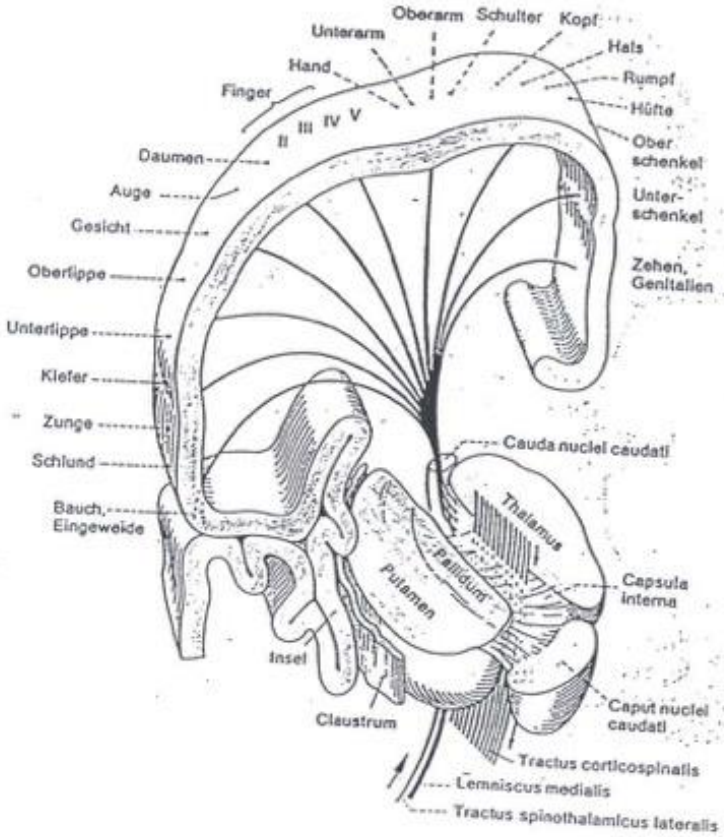


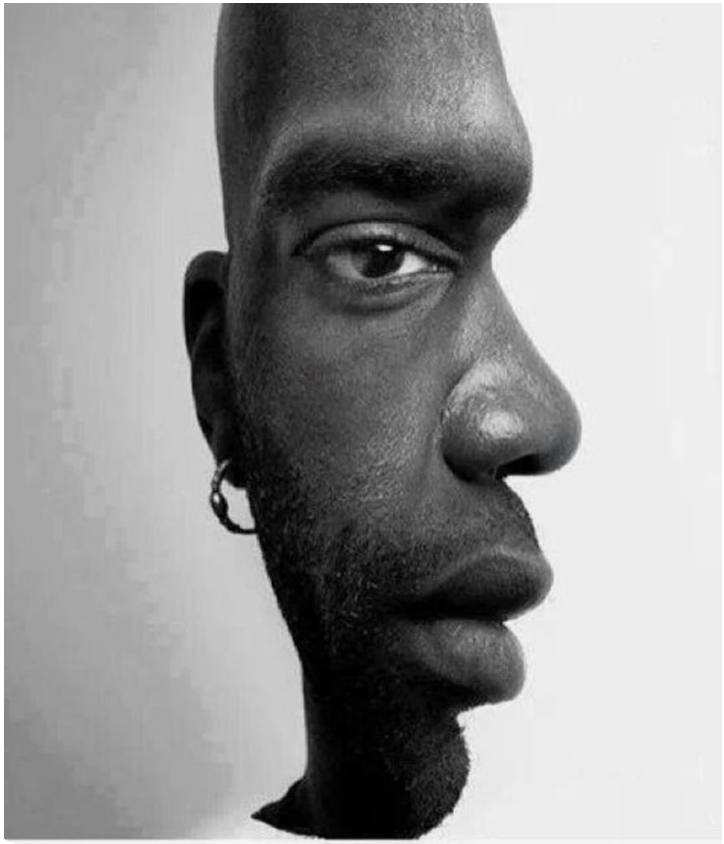
Abbildung 11.4 Zentralnervöse Weiterleitung der Somatosensorik. Die Information aus der Haut wird im Wesentlichen über das Vorderseitenstrangsystem sowie das Hinterstrangsystem zum Gehirn geleitet. Beide Systeme haben als Umschaltstelle den Thalamus und als Zielgebiete den primären und sekundären somatosensorischen Kortex

© Schandry: Biologische Psychologie, 2. überarb. Auflage. Weinheim: Beltz PVU 2006

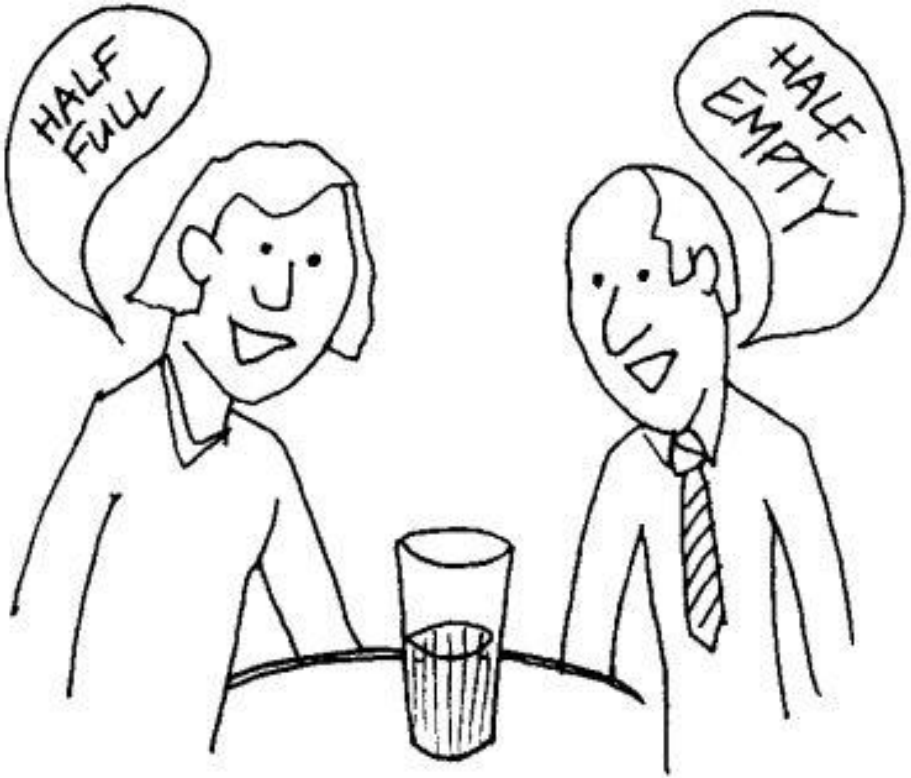
Von den Sinneseindrücken zur Wahrnehmung



Von den Sinneseindrücken zur Wahrnehmung



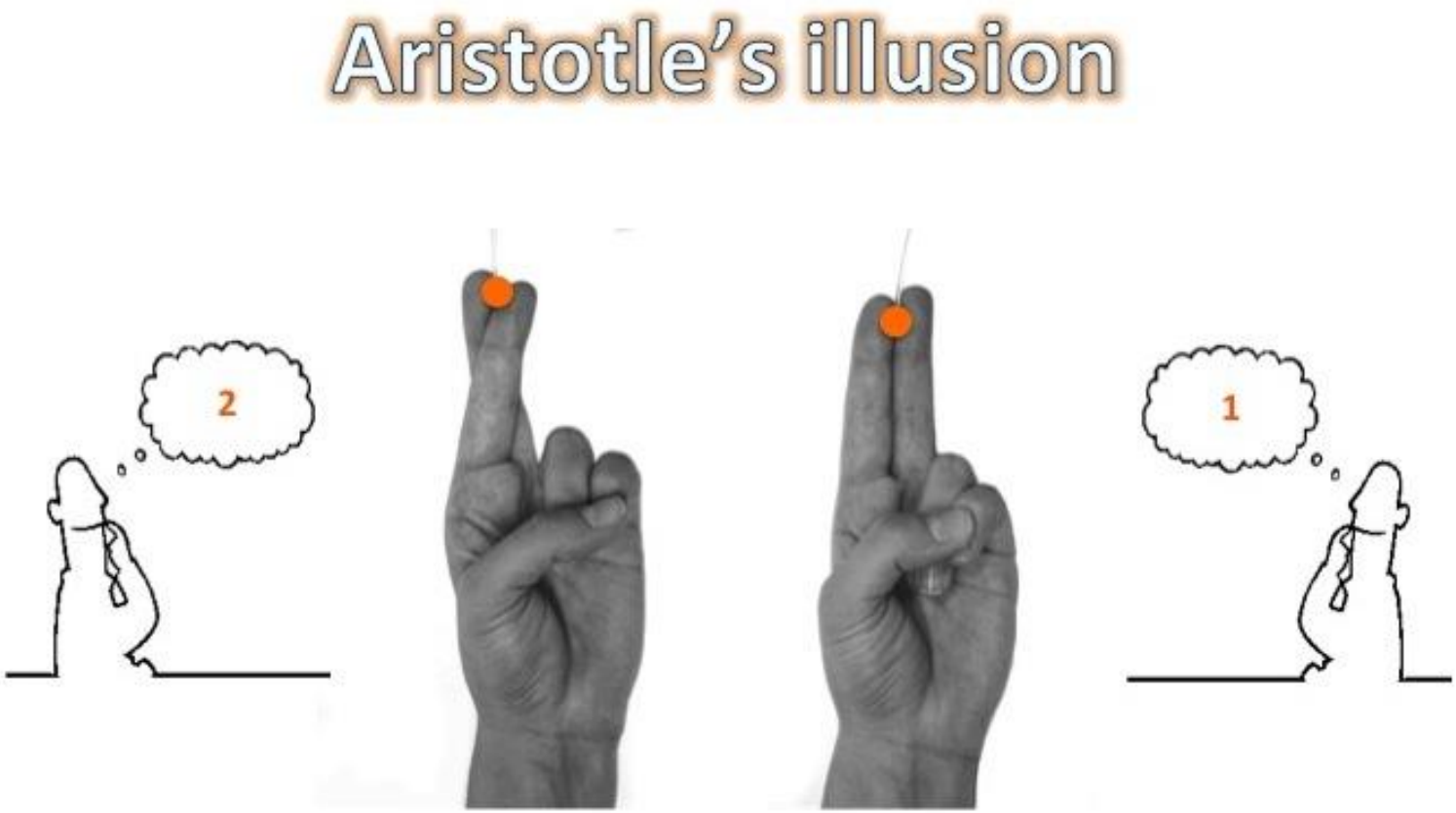
Von den Sinneseindrücken zur Wahrnehmung



Von den Sinneseindrücken zur Wahrnehmung

- Optische Illusion

Von den Sinneseindrücken zur Wahrnehmung

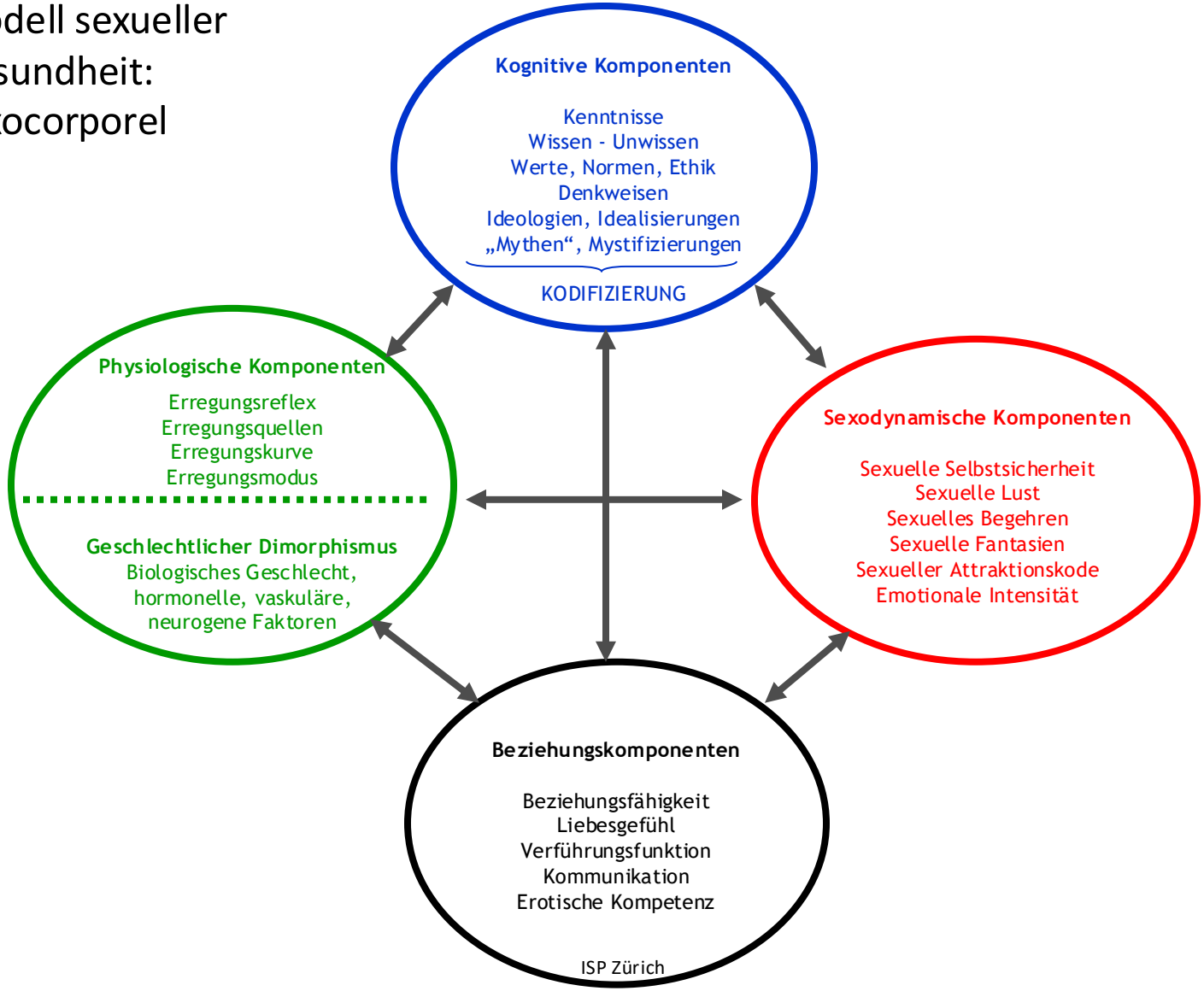


Von den Sinneseindrücken zur Wahrnehmung

Fragen?

Modell sexueller Gesundheit: Sexocorporel

isp zürich
Institut für Sexualpädagogik und Sexualtherapie



Fallbeispiel

- ... 41⁄2-jähriges Mädchen, das im Alter von 5 Monaten Versteifungsepisoden zu haben begann. Die Episoden traten auf, wenn sie auf dem Rücken lag: Überkreuzen und Versteifung der Beine, Aufrichten der Arme, "Greifbewegungen" mit den Händen und Pressen der Lippen. Ihre Atmung wurde unregelmäßig, und sie schwitzte.

- Sie traten mehrmals täglich auf und dauerten von Sekunden bis Stunden, aber ihre Eltern konnten mit ihr reden und die Anfälle stoppen. Sie sagte ihren Eltern oft, dass sie nicht aufhören könne, sondern "sich strecken müsse".

Fallbeispiel

- 4 1/2 J: Sie lag auf einem Stuhl mit angezogenen Hüften, gestreckten Beinen und gelegentlichem Scherenschnitt der beiden unteren Extremitäten. Das rhythmische Schaukeln des Beckens setzte sich fort, während sie sich mit ihren Eltern unterhielt. Gelegentlich hielt sie im Gespräch inne, machte eine Grimasse, starrte, grunzte leise und nahm das Gespräch dann wieder auf. Sie sagte, dass sie sich "dehne" und dass es nicht weh täte, sondern dass es sich "überall gut anfühle".

Fallbeispiel

- Untersuchungen: 2 Hirn MRIs, 2 EEG, 1 Röntgen des oberen Magendarmtraktes, Lumbalpunktion, Electromyographie, ausführliches Labor: alles normal.
- Beschreibung der Eltern: gescheit, energetisch.
- Entwicklung normal, allg. pädiatrische und neurologische Untersuchung normal.

Fallbeispiel

Fallbeispiel

Fallbeispiel

Archaischer Modus

Erregungsmodi

- Archaisch
- Mechanisch
- Ondulierend
- Vibrationsinduziert
- Wellenförmig

Erregungsmodi

archaisch
Tonus:
Bewegung:
Rhythmus:
Atmung:

mechanisch
Tonus:
Bewegung:
Rhythmus:
Atmung:

ondulierend
Tonus:
Bewegung:
Rhythmus:
Atmung:

wellenförmig
Tonus:
Bewegung:
Rhythmus:
Atmung:

Erregungsmodi

archaisch	
Tonus:	hoch
Bewegung:	eingeengt
Rhythmus:	eingeengt
Atmung:	eingeengt

mechanisch
Tonus:
Bewegung:
Rhythmus:
Atmung:

ondulierend
Tonus:
Bewegung:
Rhythmus:
Atmung:

wellenförmig
Tonus:
Bewegung:
Rhythmus:
Atmung:

Fähigkeiten archaischer Modus I

Über Muskelspannung die sexuelle Erregung rasch steigern

Aktivierung der Tiefenrezeptoren

Hohe muskuläre Spannung und sich über die Spannung wahrnehmend

Druck auf das Geschlecht, pressen, sehr gute Steigerung

Sehr gute Kanalisierung - es geht rasch und intensiv

Gute und rasche Entladung möglich

Kurzer Genuss der Entladung

Gut funktional einsetzbar, um unterschiedliche Spannungen loszuwerden

Vaginaler Orgasmus bei tiefer und starker Penetration

Innenwahrnehmung des Geschlechtes bleibt ein Geheimnis

Archaischer Modus bei Menschen mit Penis (MMP)

- Durch Spannung der Muskeln wird ein Pumpeffekt im Penis erzeugt und so kann es zur Ejakulation kommen. Meistens braucht es dazu noch einen Druck auf den Penis
- Da das Geschlecht aussen ist, ist die Erregungs-steigerung über die Spannung der Beckenboden-muskulatur begrenzt
- Zum Teil innerer archaischer Modus – jedoch selten
- Ca. 10% der Männer funktionieren im archaischen Modus

- Beispiele: Penis gegen etwas Hartes pressen/klemmen/drücken, Penis nach hinten binden und einklemmen oder in der Leistengegend, dazu rhythmisch oder kontinuierlich auf die Eichel drücken

Archaischer Modus bei Menschen mit Vulva (MMV)

- Atmung stark eingeengt bis fast zum Atemstillstand
- Meist erstarrt der Körper bis hin zu einer Rückwärtskrümmung, das Becken wird durch die Muskelspannung nach vorne gepresst, meist ist der ganze Körper kontinuierlich angespannt
- Erregung erfolgt über Tiefenrezeptoren (Propriorezeptoren)
- Die globale Muskelspannung beeinflusst die Wahrnehmung, Bewegung ist minimal
- Ca. 15% - 25% der Frauen funktionieren im archaischen Modus

- Beispiele: Beine zusammenpressen, auf dem Bauch liegend und Becken auf die Matratze drücken, auf der Sofakante in Grätschstellung sitzen und reiben

Mögliche Folgen archaischer Modus

- Feine Berührungen sind unangenehm

  (Die Spannung verändert die Reizleitung derart, dass es neurophysiologisch nicht mehr möglich ist, die Oberflächenrezeptoren wahrzunehmen)
- Wenig Lust auf Zärtlichkeiten
- Auswirkungen auf die Bindung:
  Wenn Oberflächenrezeptoren bzw. Berührungen nicht als angenehm empfunden werden, hat dies Auswirkungen auf die Fähigkeit berührt zu werden. Denn Oberflächenrezeptoren können die Bindung stärken, sind eine Art Bindungsrezeptoren

Mögliche Folgen archaischer Modus

- Wenn der Muskeldruck höher ist als der Blutdruck kommt es nicht mehr zur Durchblutung.
  Dadurch kommt es oft zu Erektionsproblemen und Schmerzen beim GV
- Oft Schwierigkeiten beim Oralsex
  (zu wenig Druck)
- Distanz und wenig emotionales Erleben.
  («ich liebe ihn, aber im Sex sind wir meilenweit voneinander entfernt»)

Erste Lernschritte...

- Wahrnehmen was sie oder er macht angeregt über die Fragen in der Beratung
- Tiefe Bauchatmung
- Eine kleine Bewegung zwischen angespannte Zustände und schauen, was passiert
- Anstatt pressen pulsieren, dadurch lässt der Druck etwas nach.
- Die Hand zwischen Unterlage und dem Geschlecht schieben
- Variieren der Spannung

Fragen?